

8.2.17. Mepolizumab (如 Nucala)、Benralizumab (如 Fasenra)：(113/4/1、115/4/1)

1. 用於經診斷為嗜伊紅性肉芽腫併多發性血管炎(eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, EGPA)之18歲以上成人病人，且需符合下列條件之一：

(1)復發型嗜伊紅性肉芽腫併多發性血管炎：過去2年內，曾經於使用口服類固醇 prednisolone 至少每天7.5mg 或等價當量 (equivalent) 之情況下復發 (如：增加口服類固醇劑量、或開始/增加免疫抑制劑治療、或住院等)。

(2)難治型嗜伊紅性肉芽腫併多發性血管炎：過去6個月經傳統誘導治療 (如：cyclophosphamide、或 azathioprine、或 methotrexate、或 mycophenolate mofetil、或口服類固醇 prednisolone 每天15mg 以上等) 至少3個月，仍未達疾病緩解 (未達緩解定義：口服類固醇 prednisolone 無法降至每天7.5mg 以下或等價當量)。

2. 需經事前審查核准後使用，使用52週後評估符合下列任一條件可續用：(113/4/1、115/4/1)

(1)以 mepolizumab 或 benralizumab 治療52週期間，曾經達成疾病緩解 (緩解定義：無 EGPA 病徵，且口服類固醇 prednisolone 可降至每天5mg 以下)，或

(2)於52週評估時，口服類固醇劑量相較於 mepolizumab 或 benralizumab 治療前劑量降低50%以上，或

(3)以 mepolizumab 或 benralizumab 治療52週期間，EGPA 未復發 (如：增加口服類固醇劑量、或開始/增加免疫抑制劑治療、或住院等)。

3. Mepolizumab 或 benralizumab 僅得擇一使用，惟在有耐受不良時方可轉換使用。(115/4/1)

備註：診斷為嗜伊紅性肉芽腫併多發性血管炎之定義：曾經發生氣喘伴隨嗜伊紅性白血球增多，且診斷報告須附上組織切片檢查報告，確認出現 EGPA 病徵。